

Технічна робоча група із Психічного Здоров'я та Психосоціальної Підтримки (ПЗПСП)

Протокол зустрічі

9 квітня 2026 р.

Головуючі: Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ), Міжнародний медичний корпус (IMC)

Учасники (77): UNHCR, MdM Greece, FHI 360, Проліска, Карітас-Спес Україна, Плурітон, Save the Children, Diakonie Katastrophenhilfe, MH4U, SAMS, The Lutheran World Federation, Malteser International, Enlightening Initiative, Tenth of April, CARE Ukraine, MdM France, International Committee of the Red Cross, Caritas Ukraine, Mercy Corps, Youth Movement "Be Free", REALIS, ALLIANCE.GLOBAL, Slavic Heart, Malteser Ukraine, MdM Spain, National Committee of the Ukrainian Red Cross Society, MdM Greece, UK-MED, Soleterre, Mental Health Service NGO, Міністерство соціальної політики, сім'ї та єдності України, IMC, ВООЗ та інші.

Пункти порядку денного	Основні положення зустрічі
Новини від Міністерств а соціальної політики, сім'ї та єдності України	• Проект зі створення Центрів життєстійкості (ЦЖ) було розроблено спільно з Координаційним центром з психічного здоров'я Кабінету Міністрів України у межах Всеукраїнської програми ментального здоров'я «Ти як?». • Зазначено, що це флагманська ініціатива Міністерства соціальної політики, спрямована на створення в громадах безбар'єрних просторів для надання безоплатної психосоціальної підтримки. • Найбільшим успіхом проекту було зазначено зміну підходу від кризового реагування до профілактики. • Підкреслено, що до ЦЖ можуть звертатися всі категорії населення, зокрема сім'ї, що пережили втрату, люди з інвалідністю, діти та родини, ветерани та їхні близькі, внутрішньо переміщені особи, люди старшого віку, волонтери, а також родини зниклих безвісти чи полонених. • Діяльність ЦЖ включає широкий спектр послуг: оцінку потреб клієнтів, психологічну підтримку, консультування, навчання з основ психічного здоров'я, групи самодопомоги, розвиток соціальних навичок, координацію волонтерства.

	• Загалом у ЦЖ реалізується понад 40 типів активностей, зокрема групові консультації, тематичні тренінги (щодо навичок стресостійкості, першої психологічної допомоги, самопомоги, профілактики вигорання), сімейне консультування та заходи для соціальної згуртованості. • Команди ЦЖ складаються із соціального менеджера, фахівця з соціальної роботи та психолога. Вони забезпечують діяльність ЦЖ, кейс-менеджмент, оцінку потреб і надання психологічної допомоги. • Станом на 1 квітня 2026 року в 24 областях України та м. Києві загалом функціонує 286 ЦЖ. Усього залучено близько 1400 фахівців, які надали понад 3,4 млн послуг і провели 2,2 млн активностей. Загальне фінансування проєкту перевищує 644 млн грн. • ЦЖ діють у громадах різних типів: 48,6% становлять міські громади, 24,83% – сільські, 25,87% – селищні, а також 0,7% – райони міста Києва. • Переважна більшість надавачів послуг у ЦЖ – це громадські організації та благодійні фонди (244 організації, що становить 85,31%). Також залучено 25 фізичних осіб-підприємців (8,74%), 16 комунальних некомерційних підприємств (5,59%) та 1 приватне акціонерне товариство (0,36%). • Зазначено, що наразі активно розвивається система навчання фахівців ЦЖ. Освітня модель формується як поетапний, послідовний процес розвитку компетентностей. ○ Перший етап передбачатиме проходження онлайн-курсу, створеного за підтримки ЮНІСЕФ на платформі «Дія.Освіта». Він охоплює базовий зміст послуги та алгоритми її надання. ○ Другий етап – відвідування триденних очних тренінгів, що проводяться за підтримки Банку розвитку Ради Європи. Вони спрямовані на розвиток практичних навичок, зокрема оцінки психосоціальних потреб, роботи з травмою, фасилітації груп, кейс-менеджменту, розвитку партнерств і профілактики вигорання. ○ Третій етап передбачає самооцінювання за допомогою інструментів, розроблених експертами Києво-Могилянської академії. ○ Четвертий етап – проходження спеціалізованих тематичних тренінгів, які відбуваються за підтримки ВООЗ, ЮНІСЕФ та інших партнерів. Тренінги охоплюють застосування психологічних інтервенцій, роботу зі складними випадками, волонтерський менеджмент, а також організацію груп підтримки. • Загалом уже підготовлено 1 164 фахівців за 22 темами, понад 900 осіб взяли участь у навчаннях, а навчальні програми охопили 305 команд із 24 регіонів України та міста Києва.
--	--

	• На 2026 рік заплановано розширення мережі ЦЖ (+150 громад), навчання нових фахівців (+644 фахівців) та підвищення кваліфікації для наявних команд. • Окремо анонсовано, що 24 квітня відбудеться Форум життестійкості, який має стати важливою подією для об'єднання партнерів, надавачів послуг, фахівців ЦЖ та отримувачів послуг. Захід розглядається як платформа для обміну досвідом, налагодження взаємодії, живого спілкування та підсилення спільноти через обговорення результатів, успішних практик і спільних досягнень.
Обговорення операційної діяльності ТРГ з ПЗПС	Результати тренінгу для консультантів за програмою «Управління Проблемами Плюс» (УП+) для неурядових організацій • З 30 березня по 3 квітня для представників неурядових організацій було проведено тренінг для консультантів за програмою «Управління проблемами плюс» (УП+). • Участь узяв 21 представник із 20 організацій з 12 областей України. • Наступний повторний тренінг заплановано на липень 2026 року. Тренінг «Інвалідність та інклюзія у ПЗПС» • Також анонсовано новий тренінг «Інвалідність та інклюзія у ПЗПС», що базується на рекомендаціях Міжвідомчого постійного комітету ООН (IASC). • Захід орієнтований на фахівців, які ще не мають досвіду у сфері інклюзії, прагнуть інтегрувати відповідні підходи у власну діяльність та поширювати знання у своїх організаціях. • Тренінг відбудеться 20–22 травня у Львові. • Реєстрація на тренінг доступна за посиланням, дедлайн реєстрації – 1 травня. Оновлення щодо мапування ТРГ з ПЗПС • Наразі на мапі перенаправлень ТРГ з ПЗПС представлено 92 організації. • Найбільш поширені види діяльності учасників ТРГ з ПЗПС: індивідуальне консультування (86%), психоедукація (84%), групове та сімейне консультування (68%), перенаправлення (68%). Найменш поширені: підтримка учнів у школах (23%), клінічне ведення випадків психіатром (15%), програми раннього розвитку дітей (7%). • Психологічні інтервенції надають 28 організацій (30%), психотерапію – 23 організації (25%). • Зазначено, що мапа оновлюється щомісяця, і дані про організації, чий проєкти завершилися, прибираються для уникнення відображення застарілої інформації. • Організації запрошуються оновлювати дані про проєкти у сфері ПЗПС з метою кращої координації, видимості діяльності та ефективнішого перенаправлення між надавачами послуг.

Оновлення від Ініціативи mhGAP в Україні	• Зазначено, що mhGAP є флагманською програмою ВООЗ, яка впроваджується в Україні з 2018 року. • Її мета – розширити доступ до послуг з психічного здоров'я через залучення неспеціалізованих фахівців, зокрема сімейних лікарів, медичних сестер та інших працівників первинної ланки. • Наразі до впровадження програми залучено 29 організацій. Для нових партнерів проводяться брифінги щодо проведення тренінгів та роботи в межах єдиної рамки, затвердженої Міністерством охорони здоров'я. • Впровадження навчання відбувається за стандартизованою структурою: mhGAP Частина 1 (4-денний тренінг, 29 годин, 7 модулів), mhGAP Частина 2 (додаткові 4 модулі для тих, хто завершив перший етап) та тренінг для тренерів і супервізорів. Після кожного етапу передбачена обов'язкова супервізійна підтримка. • Підкреслено, що наразі спільнота тренерів і супервізорів mhGAP налічує 732 учасники. Спільнота забезпечує обмін інформацією, координацію навчання, доступ до супервізій, збір зворотного зв'язку та поширення оновлень. • З 2023 року функціонує єдиний реєстр фахівців, навчених за програмою mhGAP, на основі якого створено аналітичні дашборди: ○ Дашборд, що відображає кількість навчених фахівців за регіонами, партнерами та спеціалізаціями; ○ Дашборд, інтегрований з даними НСЗУ, що показує заклади, фахівці яких пройшли тренінг з mhGAP, а також ті, де навчання ще не проводилось. • Окремий напрям роботи – інтеграція mhGAP у медичну освіту. У 2024 році Міністр охорони здоров'я оголосив про офіційний старт цього процесу. Відтоді 18 університетів долучилися до ініціативи, і понад 300 викладачів пройшли відповідне навчання. У 12 медичних університетах mhGAP вже викладається як курс підвищення кваліфікації, а у 6 – як обов'язкова дисципліна. • Відзначається високий інтерес до mhGAP серед студентів, а найефективнішими форматами навчання студентами було відзначено інтерактивні, кейс-орієнтовані та симуляційні підходи. • Основними запитами студентів є поглиблення тем щодо посттравматичного стресового розладу, гендерно зумовленого насильства та роботи з ветеранами. • Станом на сьогодні понад 8800 працівників первинної медичної допомоги пройшли навчання за програмою mhGAP, що становить близько 15% від загальної кількості, і майже кожен п'ятий сімейний лікар уже навчений за програмою mhGAP. • Додатково розроблено три спеціалізовані онлайн-курси mhGAP для лікарів-кардіологів, неврологів та для фахівців екстреної медичної допомоги. Вони вже доступні на платформі Академії НСЗУ за умови проходження Частин 1 і 2 загального онлайн-курсу mhGAP.
---	---

	• На 2026 рік заплановано подальше масштабування програми mhGAP, зокрема її інтеграцію в медичні коледжі, підтримку університетів через методичні матеріали та навчання викладачів, продовження навчання працівників первинної ланки та пілотування супервізійної підтримки на рівні медичних закладів.
--	---

Посилання, поширені під час зустрічі

- [Реєстрація на тренінг «Інвалідність та інклюзія у ПЗПСП»](#)
- [Мапа перенаправлень ТРГ з ПЗПСП](#)
- [Посилання на гайд по заповненню картування українською та англійською](#)
- [Сторінка mhGAP Ініціативи в Україні](#)
- [WhatsApp-спільнота mhGAP-тренерів і супервізорів](#)